

CGM-Quellen-Matrix

Welche Auflösung kriegt der User in Glev — abhängig von Sensor, Quell-App und Glev-Quelle. Stand 15.05.2026.

Quick-Lookup

SENSOR	QUELL-APP AUF DEM PHONE	GLEV-QUELLE	PUNKTE / STUNDE	LATENZ	LÜCKEN-RISIKO
Libre 2	LibreLink	LLU	4 (alle 15 min)	2–4 min	mittel — Hypos zwischen Ticks unsichtbar
Libre 2	xDrip4iOS / iAPS / Loop	Apple Health	60 (alle 1 min)	30 s – 2 min	niedrig (solange Phone in BLE-Reichweite)
Libre 2	xDrip4iOS / iAPS / Loop	Nightscout	60 (alle 1 min)	30 s – 1 min	niedrig
Libre 3	LibreLink (DACH)	LLU	4 (alle 15 min)	2–4 min	mittel — Abbott aggregiert die 1-min-Werte für die Share-API
Libre 3	LibreLink (USA/UK, älter)	Apple Health	60 (alle 1 min)	30 s – 2 min	niedrig
Libre 3	xDrip4iOS / Juggluco	AH oder NS	60 (alle 1 min)	30 s – 2 min	niedrig
Dexcom G6	Dexcom-App	Apple Health	12 (alle 5 min)	5–7 min	niedrig (Hardware-Limit)
Dexcom G7	Dexcom-App	Apple Health	12 (alle 5 min)	5–7 min	niedrig
Dexcom G6/G7	Loop / Loop Follow / xDrip	Nightscout	12 (alle 5 min)	1–3 min	niedrig

Wichtig: Glev refreshed UI alle 60 s (mit 30 s Client-Cache). Selbst bei 1-min-Datenquellen sieht der User max. 1×/min einen neuen Punkt — die Datenquelle entscheidet aber, wie viel echte Auflösung dahinter steckt.

Was bedeuten die drei Glev-Quellen technisch?

- 1. LLU (LibreLinkUp) — Cloud, alle 15 min**

Glev fragt Abbotts „Share-with-caregivers“-API alle 60 s. Abbott liefert den aktuellen Wert (live) plus die letzten ~12 h als 15-Minuten-Aggregate. Kurze Hypos/Hyper, die zwischen zwei 15-min-Ticks bottomen, sind für Glev nicht sichtbar — egal welcher Libre-Sensor. Vorteil: Null Setup. Nachteil: 15-min-Auflösung ist klinisch grob.
- 2. Apple Health — lokal, Auflösung = was die Quell-App reinschreibt**

Glev liest aus der iOS-Health-DB. Cadence ist 1:1 die der schreibenden App. LibreLink ' Health funktioniert in DACH NICHT mehr (Abbott hat den Toggle 2023 entfernt, MDR-Streit). Dexcom-App ' Health schreibt nativ alle 5 min. xDrip4iOS / iAPS / Loop / Juggluco ' Health = 1 min, weil sie den Sensor direkt via BLE auslesen. Vorteil: keine Cloud-Latenz. Nachteil: Setup nötig (Quell-App, Permissions, Glev-iOS-Shell mit HealthKit-Recht).
- 3. Nightscout — eigener Server, Auflösung = was Uploader-App pusht**

Glev pollt einen Nightscout-Endpunkt alle 60 s. xDrip / Loop / Juggluco ' NS = 1 min (Libre) oder 5 min (Dexcom-Hardware-Limit). LibreLink ' NS geht nicht direkt, brauchst eine Mittelschicht. Vorteil: Quelle der Wahrheit liegt beim User,

plattform-agnostisch (iOS + Android). Nachteil: Server-Hosting (kostenlos auf Vercel/Railway, aber Setup-Aufwand 2–4 h).

Caveats für die User-Kommunikation

- DACH-Libre-2- oder Libre-3-Nutzer ohne xDrip/Nightscout sind auf 15-min-LLU-Auflösung festgenagelt. Apple-Health-Pfad ist für sie de facto tot. Das ist nicht Glevs Fehler — das ist Abbotts Geschäftsentscheidung.
- Dexcom-Nutzer haben nie 1-min-Auflösung, egal welcher Pfad — der Sensor selbst sampled nur alle 5 min. Hardware, nicht Software.
- G7 ist nicht „besser“ als G6 in Sachen Auflösung — G7 ist nur kleiner und schneller im Warm-up.
- Latenz ` Auflösung. Eine LLU-Kurve mit 15-min-Punkten kann den letzten Wert schon nach 2 min zeigen (= geringe Latenz), die Lücken zwischen den Ticks bleiben aber leer.
- Hypo-Erkennung in Insights zählt nur Punkte unter 70 mg/dL die im Datenstrom auftauchen. Bei 15-min-LLU = nur Hypos die zufällig auf einen Tick fallen oder e15 min dauern. Bei 1-min-Quellen = praktisch alles.
- Manuelle Fingersticks umgehen die Auflösungs-Limits — werden immer gezählt und im Graph als Quadrat eingezeichnet. Wer auf LLU sitzt und ein verdächtiges Tief vermutet ' Fingerstick loggen.

Vorgeschlagene Hilfetexte für die Settings-CGM-Auswahl

LLU

„Auflösung 15 min. Einfachste Anbindung, aber kurze Hypos können fehlen — bei Verdacht zusätzlich Fingerstick loggen.“

Apple Health

„Auflösung = deine Quell-App (z. B. xDrip = 1 min, Dexcom-App = 5 min). Erfordert HealthKit-Berechtigung in der Glev-iOS-App.“

Nightscout

„Auflösung = dein Uploader (xDrip = 1 min, Loop = 5 min). Erfordert eigenen Nightscout-Server.“